

Financiamiento del sistema sanitario — FONASA, ISAPRE y seguros complementarios

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El **financiamiento del sistema de salud** constituye uno de los pilares esenciales para garantizar **acceso, equidad y calidad** en la atención sanitaria. En Chile, coexisten dos grandes regímenes de aseguramiento:

- **FONASA (Fondo Nacional de Salud)** → público.
- **ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional)** → privado.

Ambos se sustentan en un **modelo mixto de financiamiento solidario y contributivo**, donde la población destina un **7 % obligatorio de su remuneración imponible** al sistema de salud.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es de alta relevancia porque se relaciona con el rol del médico general en el sistema sanitario chileno, la comprensión del **modelo de acceso a prestaciones**, la **organización del gasto sanitario** y las **desigualdades estructurales** que el país aún enfrenta.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Principios del financiamiento sanitario

Según la **OPS/OMS**, todo sistema de financiamiento debe cumplir tres funciones básicas:

1. **Recaudación de recursos:** obtención de fondos (impuestos, cotizaciones).
2. **Acumulación o “pooling” de riesgos:** agrupar recursos y distribuirlos según necesidades.
3. **Compra de servicios:** pago a los prestadores (hospitales, clínicas, consultorios) para entregar prestaciones.

En Chile, el modelo combina solidaridad (redistribución en FONASA) con libertad de elección (ISAPRES).

2.2. Tipos de financiamiento

Tipo	Características	Ejemplo
Contributivo	Basado en cotizaciones obligatorias de trabajadores.	FONASA, ISAPRES.
No contributivo	Financiado con impuestos generales del Estado.	Atención primaria (APS), programas MINSAL.
Privado voluntario	Aportes personales adicionales o seguros complementarios.	Seguros privados, convenios institucionales.

3. Estructura del sistema chileno de financiamiento

3.1. Recaudación de recursos

- Cotización obligatoria de **7 % del ingreso imponible**.
 - Aportes fiscales directos al sistema público (~40 % del gasto total en salud).
 - Copagos y pagos directos (“gasto de bolsillo”) → alrededor del **32 % del gasto sanitario total**, uno de los más altos de la OCDE.
-

3.2. Distribución del aseguramiento (2024)

Tipo de asegurador	Población afiliada	Naturaleza
FONASA	~78 % de la población (15 millones)	Público, solidario.

ISAPRES	~15 % (2,9 millones)	Privado, contributivo.
Fuerzas Armadas y de Orden (CAPREDENA/DIPRECA)	~3 %	Sistemas cerrados.
No asegurados / otros	~4 %	Migrantes o trabajadores informales.

4. FONASA — Fondo Nacional de Salud

4.1. Naturaleza y objetivos

Creado en 1979, FONASA es el **seguro público de salud** que recauda, administra y distribuye los fondos destinados a la atención médica de la población beneficiaria.

4.2. Financiamiento

- **Aportes:** 7 % de cotización obligatoria + aportes fiscales del Estado.
- **Principio rector: solidaridad inter e intra-grupal:** quienes ganan más contribuyen más; quienes necesitan más, reciben más.

4.3. Modalidades de atención

Modalidad	Descripción	Ejemplo
Modalidad institucional (MI)	Atención en red pública (consultorios, hospitales). Sin pago directo.	APS, hospital público.
Modalidad libre elección (MLE)	Atención en prestadores privados en convenio. Paciente paga copago según tramo.	Consulta con especialista en clínica privada asociada.

4.4. Tramos de afiliación

Tramo	Ingreso mensual (referencial 2024)	Cobertura	Copago
A	Sin ingresos o indigentes	100 % cobertura en MI	0 %
B	Hasta \$500.000	100 % MI	0 %
C	\$500.001 – \$730.000	90 % MI	10 %
D	> \$730.000	80 % MI	20 %

Nota: todos los tramos acceden al **AUGE/GES**, **urgencias vitales** y **Ley Ricarte Soto**.

4.5. Compra de servicios

FONASA **compra servicios** a los prestadores públicos y privados según criterios de costo-efectividad, priorizando las **garantías GES**, atención APS y programas preventivos.

5. ISAPRES — Instituciones de Salud Previsional

5.1. Naturaleza y funcionamiento

Son **entidades privadas** que administran el 7 % de la cotización de salud, entregando planes individuales o familiares.

Pueden ser **abiertas** (para cualquier persona) o **cerradas** (para empresas específicas).

5.2. Características principales

- Financiamiento mediante cotización individual.
- Planes de salud ajustados por **edad, sexo y riesgos** (históricamente discriminatorios).

- Libre elección de prestadores.
- Posibilidad de seguros complementarios.

5.3. Regulación

Supervigiladas por la **Superintendencia de Salud** (creada en 2005).

Desde 2019, existe debate y reforma estructural debido a fallos judiciales por **discriminación y tabla de factores**.

5.4. Cobertura y gasto

- Gastan casi **el doble por beneficiario** que FONASA.
 - Concentran la atención de especialistas y clínicas privadas.
 - Cobertura del **100 % en GES**, aunque con mayor copago fuera de la red.
-

6. Seguros complementarios y privados

Existen **seguros voluntarios adicionales** contratados por personas naturales o empleadores para cubrir:

- Copagos en FONASA o ISAPRE.
- Medicamentos no cubiertos por GES.
- Cirugías o procedimientos costosos.

Ejemplo: seguros institucionales de universidades o empresas.

También operan **seguros catastróficos** (ej. Ley Ricarte Soto) y **seguros internacionales** para tratamientos fuera del país.

7. Ley Ricarte Soto y mecanismos de protección financiera

La **Ley N.º 20.850 (2015)** creó el **Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo**, conocido como **Ley Ricarte Soto**, que garantiza la cobertura total de patologías de alto costo previamente evaluadas como **eficientes, efectivas y equitativas**.

Ejemplos actuales: fibrosis quística, esclerosis múltiple, hemofilia, ciertos cánceres y enfermedades lisosomales.

Cada tratamiento cubierto pasa por un análisis de costo-utilidad (ETESA) y evaluación presupuestaria.

8. Comparación entre FONASA e ISAPRES

Aspecto	FONASA	ISAPRES
Tipo de financiamiento	Público y solidario	Privado y contributivo
Recaudación	7 % + aportes fiscales	7 % + cotización adicional
Población afiliada	78 %	15 %
Cobertura GES	Total	Total
Equidad	Alta (redistribución)	Baja (discriminación por riesgo)
Prestadores principales	Públicos	Privados
Mecanismo de pago	Per cápita, prestación, programa	Plan individual contratado

Desafíos actuales

Listas de espera, financiamiento
insuficiente

Reformas judiciales,
sostenibilidad económica

9. Situación sanitaria y desafíos actuales (2024–2025)

1. **Envejecimiento poblacional:** presión sobre FONASA y hospitales públicos.
 2. **Reforma estructural pendiente:** proyecto de **Fondo Universal de Salud** en debate parlamentario.
 3. **Crisis del modelo ISAPRE:** déficit financiero, judicialización y necesidad de rediseño del aseguramiento privado.
 4. **Altos gastos de bolsillo:** 32 % del total, limitando el acceso equitativo.
 5. **Brecha público–privado:** persistente desigualdad en tiempos de espera y acceso a especialistas.
-

10. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

Programa / Ley	Institución	Objetivo
Estrategia Nacional de Salud 2021–2030	MINSAL	Fortalecer la equidad y eficiencia del sistema mixto.
Ley N.º 18.469 (1985)	MINSAL	Establece el régimen de prestaciones de salud y crea FONASA.
Ley N.º 18.933 (1989)	Superintendencia de Salud	Regula ISAPRES.

Ley N.º 20.584 (2012)	MINSAL	Derechos y deberes de las personas en salud.
Ley N.º 20.850 (2015)	MINSAL	Crea la Ley Ricarte Soto (protección de alto costo).

11. Rol del médico general y competencias en APS

Rol	Ejemplo
Agente de equidad	Garantizar atención oportuna sin discriminación por previsión.
Gestor local	Conocer tramos FONASA, modalidades y mecanismos de derivación.
Educador sanitario	Orientar a pacientes sobre beneficios GES y cobertura pública.
Participante en políticas de red	Colaborar con SEREMI y Servicios de Salud en optimización de recursos.

El médico general, especialmente en APS, es el **punto entre la estructura financiera y la atención efectiva**, garantizando uso racional de los recursos y priorización de los grupos más vulnerables.

12. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
------------------------	------------------------------

Pensar que FONASA cubre solo al 7 % más pobre Cubre al 78 % de la población chilena.

Confundir “público” con “gratuito”

FONASA tiene copagos según tramo, salvo A y B.

Afirmar que ISAPRES no cubren GES

GES es obligatorio para todos los seguros.

Ignorar el rol redistributivo del Estado

El financiamiento público busca compensar desigualdades.

Creer que los seguros complementarios reemplazan al GES

Solo amplían cobertura o reducen copagos.

13. Complicaciones y pronóstico

- **Sostenibilidad fiscal:** gasto público creciente por envejecimiento y tecnologías de alto costo.
- **Reforma ISAPRE:** necesaria para asegurar continuidad del aseguramiento privado.
- **Desigualdad estructural:** brechas en acceso entre sectores público y privado.
- **Desafío político:** avanzar hacia **un sistema universal, equitativo y sustentable**, manteniendo libertad de elección.

Pronóstico 2030:

El sistema chileno evolucionará hacia un **Fondo Universal de Salud solidario**, con unificación gradual del financiamiento, fortalecimiento de APS y evaluación económica de todas las nuevas prestaciones.

14. Referencias ministeriales y técnicas

- **MINSAL (2024). Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.**
 - **Superintendencia de Salud (2023). Informe Financiero Anual.**
 - **FONASA (2024). Estadísticas institucionales y tramos de afiliación.**
 - **OPS/OMS (2022). Financiamiento sostenible de los sistemas de salud.**
 - **Ley N.º 20.850 (Ley Ricarte Soto). Diario Oficial de Chile.**
-

15. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. El **financiamiento sanitario chileno** es mixto: público (FONASA) y privado (ISAPRES).
2. Todos los trabajadores destinan un **7 % de cotización obligatoria**, con diferentes mecanismos de redistribución.
3. **FONASA** cubre al 78 % de la población bajo principios de solidaridad; **ISAPRES**, al 15 %, con libertad de elección.
4. Los programas **GES y Ley Ricarte Soto** garantizan equidad en patologías prioritarias y de alto costo.
5. Los **seguros complementarios** amplían cobertura, pero aumentan la segmentación del sistema.
6. El **médico general** debe comprender los mecanismos financieros para orientar adecuadamente a sus pacientes.
7. El futuro del sistema apunta hacia un **modelo universal, solidario y sustentable** que reduzca las inequidades en salud.